5.C

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno (a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Kelly Montenegro Salinas					Sexo	F	X	M
Fecha Nacimiento	28/07/2014	Edad actual	10 años	9 meses	País natal:	Chile			
Domicilio actual:	Oscar Bermudez 1551 Los Andes				Teléfono	985185408 - 967000561 (Abuela).			
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☒ escribe ☐						
Lengua de uso	~~Español~~	Grado dominio	comprende ☒ habla ☐ lee ☐ escribe ☐						
Escolaridad actual:	5°A	Establecimiento	**Liceo Mixto Los Andes Básico N°1**						

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 09/04/2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Elisa Salinas	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 09/04/2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Paula Quisostozo	Nombre:
Rol/cargo: Docente PIE.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

- Se asiste con facilidad - olvida las cosas (a veces).
- Antecedentes de postulación al PIE en 2° o 3° básico con Dg. FIL (Ver).

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí **(especificar)**

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro: PIE / FIL.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA

Ley 20.201 – Decreto N...

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO

Peso: 3,200 kgs. Talla: 48 cms.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

- Pasó el tiempo que correspondía. Se puso tensa.
A pabellón. Controlada. No se dilató.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Si	~~No~~	Traumatismos	Si	~~No~~	Encefalitis	Si	~~No~~
Obesidad	Si	~~No~~	Intoxicación	Si	~~No~~	Meningitis	Si	~~No~~
Fiebre alta	Si	~~No~~	Enfermedad respiratoria	Si	~~No~~	Otra(s)	Baja de peso al nacer (2,60 kg).	
Convulsiones	Si	~~No~~	Asma	Si	~~No~~			
Hospitalizaciones	Si X	No	Especifique motivos y duración: Ictericia (Piel amarilla)					

Se realizaron controles periódicos de salud: ~~Si~~ No

Vacunas: ~~Si~~ No

Observaciones:

Atención en Hospital por ictericia (Controlada). -

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 3, 1/2 meses.	Se sienta sólo/a: 8-9 meses	Camina sin apoyo: 1 año.
Primeras palabras: 4 meses	Primeras frases: 11 meses	Se viste solo/a: 2, 1/2 años.

Controla esfínter vesical — Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Controla esfínter anal — Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Observaciones:

- No se expresan al funciones en el área.
- 10 meses saca Parietales. -

En su actividad motora general se aprecia: ☐ normal ☐ activo ☒ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia: ☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Si~~	No	Caídas frecuentes	Si	~~No~~	Dominancia lateral	Si	~~No~~

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Si~~	No	Prensión	Si	~~No~~	Pinza	~~Si~~	No
Ensarta	~~Si~~	No	Dibuja	Si	~~No~~	Escribe	~~Si~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Si~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Si~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Si~~	No	Comprende prohibiciones	~~Si~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Si~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	~~Si~~	No

Observaciones:

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí ✓	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí ✓	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No ✗	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí ✓	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí ✓	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí ✓	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No ✓
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí ✓	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí ✓	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No ✓	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No ✓
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No ✓	La pronunciación oral es adecuada	Sí ✓	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No ✓	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No ✓

Observaciones: Frunce el ceño = de lejos no ve. Dificultad en pronunciación de "ll" – en ocasiones levanta mucho la voz (Gritar).

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí ✓	No	Emite/produce frases	Sí ✓	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí ✓	No	Relata experiencias	Sí ✓	No
Emite palabras/produce señas	Sí ✓	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí ✓	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí ✓	No	Sigue instrucciones simples	Sí ✓	No ✓
Identifica personas	Sí ✓	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No ✓
Comprende conceptos abstractos	Sí ✓	No	Sigue instrucciones grupales en casa cuesta	Sí ✓	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí ✓	No ✓	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí ✓	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): NO. –

Observaciones: Expresa palabras de comprensión (Cuento de mamá, Kelly comprende).–

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí ✓	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí ✓	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí ✓	No ✓	Respeta normas sociales	Sí	No ✓
Participa en actividades grupales	Sí ✓	No	Respeta normas escolares	Sí ✓	No
Opta por trabajo individual Cuesta	Sí ✓	No	Muestra sentido del humor	Sí ✓	No
Presenta lenguaje ecolálico (repite palabras, silabas, etc.) A veces.–	Sí ✓	No	Movimientos estereotipados (repetitivos)	Sí	No ✓
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No ✓	Pataletas frecuentes	Sí ✓	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☐ natural ☑ desmesurada	☐ natural ☑ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones:
- Introvertida - no cuenta sus cosas, en ocasiones mucho por cosas mínimas.

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	Sí ✓	No	Trastorno motor	Sí	No ✓
Epilepsia	Sí	No ✓	Problema bronco-respiratorio	Sí	No ✓
Problemas cardiacos	Sí	No ✓	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No ✓
Paraplejia	Sí	No ✓	Trastorno emocional	Sí	No ✓
Pérdida auditiva	Sí	No ✓	Trastorno conductual	Sí	No ✓
Pérdida visual			Otro (especifique):	Sí	No ✓

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Sí.

Alimentación: ✓ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ✓ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo ✓ inquieto Horas que duerme: 6 Horas.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ✓ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ✓ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☐ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro: De todo un poco.

Observaciones:

- NO COME MARISCOS
- Cuenta que se quedó dormida (ve tele).
- sonambulismo (Año 2023 o su explicación).-

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Elsa Salinas	Madre	36	4to.	Vendedora
2. Elisa Santander	Abuela	71	4to	Dueña de casa.
3. Edson Aguilar	Hermano	4	PK	Estudiante.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

- Madre Diabetes en Tto. -
- Abuela también + hipertensión tomar Autoritina. -

Observaciones:

Muerte de Hermano de Madre por Cáncer Testicular.-

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	7 años	Asistió a jardín infantil	Sí ✓ / No
N° de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza: Regular ✓ Especial ☐ Técnica ☐:	
Motivo de los cambios:	Pasó B2 a Pasó B1		
Ha repetido curso/s	Sí / No ✓	Curso(s)	Motivo: —

Situación actual

Nivel/curso actual	5°A	**Dificultad de aprendizaje**	Sí ✓	No	**Dificultad para participar**	Sí	No ✓	**Conducta disruptiva**	Sí	No ✓
Asiste regularmente	Sí ✓ / No	**Asiste con agrado**	Sí ✓	No	**Apoyo familiar en tareas**	Sí ✓	No	**Amigos (as)**	Sí	No ✓

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☐ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☑ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

...MENTO SON CONFIDENCIALES. SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA

Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

8. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL ESTABLCIMIENTO

Permanencia

(Señale aquellos antecedentes en relación a la permanencia del estudiante en el establecimiento, por ejemplo, se traslada de una ciudad a otra de manera constante, tiene considerado retirarlo del establecimiento antes que termine el año, etc.):

Permanencia total.-

- Posibles ataques de ansiedad -
- Tirita cuando le llaman la atención.
- Se frustra con facilidad.

Observaciones:

* Cambio de dirección (en trámite). "Las tomas".-

Requiere de atención de psicológica de manera urgente.-

Llama la atención cuando no le dan las cosas que necesita (Ej: celular).-

Expresa dispo la ita, situación de suicidio.-